•Melhoria do acesso e da assistência integral à mãe e ao bebê;
•Impacto positivo na redução da mortalidade infantil.
A estruturação da visita domiciliar com ferramentas práticas potencializou o engajamento das equipes e impactou positivamente os indicadores materno-infantis. Embora bem-sucedida e expandida, a iniciativa enfrenta de
•Impacto positivo na redução da mortalidade infantil.

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Fortalecimento da visita domiciliar na primeira semana de vida como estratégia de redução da mortalidade infantil na AP 5.1 do Rio de JaneiroTrabalho

Autores:
Erivelto Soares*, Larissa Torres Santos Alves*, Patrícia Vaz Guimarães*, Raphael Costa Pinto*, Victor Costa Da Silvanculo*.
*SMS - Rio de Janeiro

Uso da maleta pelas equipes de ESF.

PRINCIPAIS ACHADOS:

- Fortalecimento do estímulo profissional para visitas domiciliares;
- Melhoria do acesso e da assistência integral à mãe e ao bebê;
- Impacto positivo na redução da mortalidade infantil (2022).

Gráfico: Série histórica da taxa de mortalidade infantil: AP 5.1 e Município do Rio de Janeiro, 2011-2026.

Introdução

A mortalidade infantil persiste como um grave desafio à saúde pública brasileira, estando intrinsecamente vinculada a iniquidades sociais como baixa renda, escolaridade precária e acesso limitado a serviços de qualidade. Na Área Programática (AP) 5.1, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, esse cenário é agravado pela acentuada vulnerabilidade socioeconômica e pela violência territorial. Tais determinantes impactam negativamente os indicadores materno-infantis locais. Nesse contexto, a visita domiciliar no âmbito da Estratégia de Saúde da Família consolida-se como tecnologia de cuidado essencial para mitigar iniquidades e assegurar a integralidade da assistência ao binômio mãe-bebê.''

Objetivos

Relatar a experiência de aprimoramento da visita domiciliar ao recém-nascido na primeira semana de vida através da estruturação de protocolos e da implementação de equipamentos móveis de suporte.

Métodos

Trata-se de um relato de experiência sobre a estruturação e implementação no ano de 2022 de um programa de qualificação da assistência domiciliar na AP 5.1 (Rio de Janeiro). O processo metodológico estruturou-se em quatro eixos operacionais:

1- Criação de ferramentas de monitoramento para busca ativa de gestantes no último trimestre e puérperas;

2- Instituição de um protocolo de atendimento multiprofissional no domicílio e nas maternidades para as crianças internadas;

3- Desenvolvimento e distribuição de 160 "Maletas Móveis" para as equipes, contendo equipamentos básicos para o exame físico e acolhimento domiciliar;

4- Treinamento das equipes para o uso do kit e adesão voluntária ao novo modelo de acompanhamento.

Resultados

O programa obteve 80% de adesão das equipes do território. A introdução da "maleta" funcionou como um elemento de valorização profissional e identidade do SUS, aumentando o estímulo para a realização das visitas. No primeiro ano de implementação, a AP 5.1 atingiu a menor taxa de mortalidade infantil de sua série histórica (9,31/1000). O sucesso da iniciativa levou à expansão do modelo da maleta para outras Áreas Programáticas da cidade. Como barreiras, observam-se as dificuldades de manutenção do programa diante da rotatividade de profissionais, das restrições de acesso impostas pela violência armada e do próprio caráter multifatorial da mortalidade infantil.

Conclusão/Considerações finais

A estruturação da visita domiciliar com ferramentas práticas potencializou o engajamento das equipes e impactou positivamente os indicadores materno-infantis. Embora bem-sucedida e expandida, a iniciativa enfrenta desafios estruturais, como a insegurança nos territórios e a rotatividade de pessoal, que exigem estratégias contínuas de gestão e apoio institucional, além de outros fatores intersetoriais relacionados ao caráter multifatorial da mortalidade infantil.

INSTITUIÇÃO
Erivelto Soares de Medeiros Junior
SMS/SUBPAV/CAP 5.1

E-mail: erivelto.medeiros@outlook.com
Contatos: 21 – 98746-4520
INSTAGRAM CAP 5.1:

PREFEITURA RIO | Saúde | SUS